

Zobacz strukturę — *co waży w Twojej samoocenie*

Koło dzielone na „kawałki” według wagi każdej domeny w samoocenie pacjenta. W AN typowo 70–90% to kontrola wagi. Cel: rozszerzyć, nie wyeliminować.

CZAS: 30 min na sesji + zadanie domowe **REALIZACJA:** faza 2 CBT-E, po psychoedukacji nadwartościowania

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, rozdz. 8, *self-evaluation pie chart*); Cooper, Fairburn & Hawker (2003); Geller i in. (1998)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **jak narysować** pie chart krok po kroku + typowy obraz w AN (przed/po terapii). Sekcja 02 — **siedem kroków pracy**: od diagnozy do planu rozszerzania. Sekcja 03 — **mój pie chart** do wypełnienia (teraz i cel).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pie chart samooceny (Fairburn, 2008) — wizualizacja struktury samooceny pacjenta. Pacjent rysuje koło i dzieli je na „kawałki” o rozmiarach proporcjonalnych do **wagi** każdej domeny w jego samoocenie (nie do czasu jej poświęcanego — to różnica). W AN typowo: 70–90% to kontrola wagi/jedzenia, reszta marginalna. **Mechanizm terapeutyczny:** wizualizacja czyni problem **widocznym** — pacjent po raz pierwszy „zobaczy” nadwartościowanie. Cel pracy: **rozszerzyć**, nie wyeliminować — docelowo żadna domena >30–40%, reszta rozłożona między kilka domen. To dotyczy zdrowej osoby również.

01 Pie chart krok po kroku

TYPOWY OBRAZ W AN — PRZED

Kontrola wagi/jedzenia: 70–90%. Reszta marginalna: szkoła/praca 5–10%, relacje 0–5%, hobby/pasje 0–5%, wartości 0–5%. Pacjent po raz pierwszy **widzi**, jak nieproporcjonalnie wszystko buduje na jednym filarze.

CEL TERAPII — DOCELOWO

Żadna domena >30–40%. Praca 25%, relacje 20%, hobby/pasje 15%, wartości 15%, kontrola wagi 15%, inne 10%. To nie „*brak troski o ciało*” — to *proporcja*. Zdrowa osoba ma podobny rozkład.

Jak rysować: (1) duże koło na kartce A4; (2) pacjent *sam* dzieli na kawałki — terapeuta nie podpowiada; (3) podpisuje każdy kawałek nazwą domeny (kontrola wagi, praca, relacje, hobby, ...); (4) przy każdej domenie zapisuje procent wagi w samoocenie (*nie* czasu poświęcanego — to inna rzecz); (5) suma = 100%.

Waga ≠ czas. Pacjent może codziennie pracować (8h) i nigdy nie myśleć o tym jako o części samooceny. To różnica między „co robię” a „na czym buduję poczucie wartości”.

02 Siedem kroków pracy z pie chart

1. **Wprowadzenie** — „Spróbujmy zobaczyć, na czym budujesz swoją samoocenę. Nie chodzi o to, co robisz na co dzień — chodzi o to, co Cię definiuje jako osobę”. Pacjent rysuje koło na kartce A4.
2. **Pacjent dzieli koło** — *sam/-a*, bez podpowiedzi terapeuty. Każda domena — kawałek odpowiadający wadze w samoocenie. Suma = 100%.
3. **Analiza wspólna** — bez oceniania. Pytaj: „Co widzisz, kiedy patrzysz na to koło?” Pacjenci często reagują zaskoczeniem, smutkiem lub obroną („tak jest u wszystkich” — nieprawda).
4. **Pie chart „cel”** — pacjent rysuje *drugie* koło — jak chciałby/-a, żeby wyglądała jego samoocena za rok. Typowo: ten cel ujawnia, których domen pacjent *chciałby* w sobie więcej.
5. **Plan rozszerzania** — wybierz 2-3 domeny z „celu”, w których jest miejsce na rozwój. Konkretnie małe kroki w tym tygodniu, miesiącu, kwartale. Nie „będę bardziej kreatywny/-a”, lecz „w środę pójde na warsztaty rysunku”.
6. **Monitorowanie co 2-3 miesiące** — pacjent rysuje *nowy* pie chart i porównuje z poprzednim. Czy domena „kontrola wagi” się skurczyła? Czy inne wzrosły? Wizualizacja zmiany motywuje.
7. **Praca z oporem** — typowo pacjent: „ale kontrola wagi jest ważna, nie chcę jej zmniejszać”. Odpowiedź MI: „Tak — i może dodatkowo zauważasz, że gdyby było coś poza tym, bezpieczeństwo by się zwiększyło”. Bez konfrontacji.

03 Mój pie chart — teraz i cel

DOMENA	% W MOJEJ SAMOOCENIE TERAZ	% CEL ZA ROK
Kontrola kształtu/wagi/jedzenia		
Praca / nauka		
Relacje (rodzina, przyjaźnie)		
Hobby, pasje, kreatywność		
Wartości, działalność społeczna, duchowość		
Inne (podpisz)		
RAZEM	100%	100%

Klucz: pie chart to *jedna z najmocniejszych* interwencji CBT-E — daje pacjentowi *wizualizację* problemu, który wcześniej był abstrakcyjny. Częsta reakcja: „nie wiedziałem/-am, że to tak wygląda”. To otwiera drzwi do pracy. **Komunikat dla pacjenta:** „nie chodzi o to, żeby kontrola wagi zniknęła. Chodzi o to, żeby przestała być jedynym filarem. Jeśli filar pęknie, cały dom się zawali. Jeśli filarów jest pięć — jeden może się chwiać, a Ty stoisz”.

⚠ **Pie chart sam w sobie nie wystarczy** — bez konkretnych zadań w nowych domenach (sekcja 02, krok 5) pozostaje teorią. Pacjent potrzebuje *realnych doświadczeń*, które wzmocnią inne domeny — drobne osiągnięcia, więzi, pasje. Rozszerzanie samooceny to *praca*, nie *wgląd*.